Relazione sulla visita al Reparto B 3 di Grugliasco

Visita effettuata giovedì 19 luglio 73 dalle ore 18,15 alle ore 20 dal gruppo composto da Palazzo, Morteo e Giordanengo.

Direzione del Reparto: dott. Re; sostituto dott. Cogo

Il reparto, femminile, composto di lungodegenti prevalentemente anziane, ha una capienza di 120 posti; attualmente sono ricoverate 107 malate.

Descrizione del reparto : i locali si distribuiscono su due piani; al pianterreno vi sono due refettori, di cui uno adibito anche a soggiorno e l'altro riservato alle malate "che si sporcano di più"; un terzo refettorio si trova al primo piano, per le malate che hanno difficoltà a scendere. Al pianterreno si trovano anche la cucina, la lavanderia, i locali per il medico, per le visite dei parenti, ecc. Al primo piano vi è un ampio locale riservato ai lavori di stiratura, cucito ecc. I dormitori (4) sono grandi (18-20 letti ciascuno); alle estremità dei dormitori vi sono alcune camerette a due letti, riservate alle malate più autosufficienti e ordinate. Il reparto dispone di due apparecchi televisivi, uno per piano. Al reparto è annesso un giardino, un tempo ricco di alberi e d'ombra; lo scorso anno molti alberi furno abbattuti a causa di certi lavori di canalizzazione che hanno attraversato il giardino: di ciò si dispiacciono le malate e il personale.
Servizi igienici : vi sono 6 posti di gabinetto per piano, con quattro coppie di lavandini e tre bagni per piano. Oltreché essere insufficienti come numero, data l'ampiezza del reparto (si fa il bagno alle ammalate in media ogni 10-15 giorni), questi servizi sono oltremodo vetusti, sbreccati se non addirittura rotti, con porte sgangherate quando non mancanti (Peraltro molte malate sono incontinenti e vanno cambiate a letto). Nonostante queste pessime condizioni dei servizi (da anni è stata richiesta la loro sostituzione), essi non sono sporchi né maleodoranti.

Condizioni del reparto : l'ordine e la pulizia sono infatti una netta caratteristica del reparto (pareti imbiancate, pavimenti puliti, tende alle finestre ecc.). All'ora della nostra visita (il pasto serale era appena terminato, molte malate erano già a letto) si stava procedendo alacremente al riordino dei refettori e alla rigovernatura dei piatti. Nessun letto risultava malfatto o trascurato; tutto era in ordine sia nei grandi dormitori che, soprattutto, nelle linde camerette a due letti. Va subito osservato che a questa opera di pulizia concorrono validamente le malate, ed è probabile che, senza il loro concorso, il reparto sarebbe assai più malandato.

Le infermiere sono in totale 22 fisse + 8 supplenti (di notte vi sono 3 infermiere). Le inservienti sono 8, 3 per turno, non molte data l'ampiezza del reparto e il numero delle malate. Durante la nostra visita, abbiamo visto parecchie ricoverate spazzare il refettorio e lavare i piatti. Sia le infermiere che la suora capo-reparto affermano che il lavoro delle malate è assolutamente volontario e che la sua scelta è libera (così confermano alcune malate, cui abbiamo domandato se fossero contente di fare quel lavoro e se volessero cambiarlo). Trattandosi però di degenti anziane e da lungo tempo ricoverate, si ha piuttosto l'impressione che questo lavoro costituisca un'abitudine inveterata e ormai per così dire meccanica: talché, ad esempio, un'ammalata non saprebbe più concepire la sua giornata, se non inframmezzata con il rigoverno dei piatti o la spazzatura dei pavimenti, o altro. Quindi, a rigore, non si potrebbe parlare di "libera scelta" né tantomeno di "partecipazione" alla vita del reparto. Tuttavia, data la carenza quasi totale di altre attività occupazionali nel reparto, non si vede come condannare la pratica di questo lavoro. Da notare che esso

viene modestamente remunerato (5.000 lire ogni dieci giorni). Oltreché della pulizia dei reparti, le malate si occupano anche della propria biancheria personale: questa viene lavata a macchina a pianterreno, quindi aggiustata e stirata a cura delle ricoverate. Talune di esse lavorano anche fuori del reparto (negli uffici e nel guardaroba; il loro compenso è di 5.500 lire ogni dieci giorni). Nessuna malata lavora fuori dell'ospedale. Le malate possono uscire dal reparto, andare al bar, recarsi al paese per acquisti, ecc.

Nella nostra visita siamo state dapprima accompagnate dalla suora capo-reparto (suor Robertina) che ci ha accolte senza diffidenza, con la sicurezza - si potrebbe dire - di chi sa "che tutto è a posto". Suor Robertina di occupa da 20 anni delle malate di mente, prima in via Giulio ed ora a Grugliasco. E' una donna ancora giovane, dal piglio cordiale e attivo. (A proposito di via Giulio, afferma che su questo ospedale "si sono fatte molte chiacchiere", che le malate non vi stavano poi così male, che molte non volevano andarsene, che talune addirittura potendo vi ritornerebbero. Tuttavia riconosce che tutto ciò era forse solo questione di abitudine e che ora a Grugliasco sotto certi aspetti la sistemazione è migliore. I servizi igienici però erano molto migliori in via Giulio; inoltre le malate, quando uscivano, avevano i negozi a portata di mano, mentre qui le distanze sono maggiori. Afferma che molte malate hanno accettato il trasferimento a Grugliasco solo per seguirla, perché a lei molto affezionate). Suor Robertina è presente nel reparto dalle ore 7 alle ore 19. Essa sostiene che il dott. Re viene nel reparto tutti i giorni dalle ore 9 alle 12 e dakke 14 alle 16. Anche lo psicologo (dott. Ferrero) verrebbe tutti i giorni e altrettanto farebbero le assistenti sociali. Le malate conoscerebbero l'esistenza sia dell'uno che delle altre e potrebbero chiedere liberamente di consultarli. Lo psicologo avrebbe sottoposto le malate a test proiettivi. Anche i colloqui del dott. Re con le malate sarebbero liberi e frequenti; il dott. Re si interesserebbe di tutte le malate. (Psicologo e assistenti sociali sarebbero assenti solo il sabato e la domenica). Alle 19 la capo-reparto, finito il suo orario, se ne va e noi abbiamo un colloquio diretto con le infermiere.

Queste confermano che il dott. Re viene nel reparto tutte le mattine e si interessa di tutte le ammalate; spesso egli viene anche nel pomeriggio. Inoltre, essendo medico generico oltreché psichiatra (per molti anni è stato a capo dell'infermeria) si occuperebbe delle malate anche sotto il profilo sanitario generale, cosa molto utile in un reparto con molte degenti anziane. Le infermiere si dimostrano nel complesso soddisfatte dell'organizzazione del reparto; lamentano solo la decrepitezza dei servizi e la pesantezza del loro compito (molte malate non si contengono; data l'età avanzata e il lungo deterioramento sono poco recuperabili : "qui vengono radunati gli scarti dell'ospedale"). Desidererebbero perciò uno sfoltimento delle malate meno autosufficienti. Non si tengono riunioni collettive del personale (anche per la difficoltà di essere tutti presenti), riunioni che peraltro - esse riconoscono - sarebbero molto utili per scambi di idee e consigli. Mostrano di avere buoni rapporti con la suora capo-reparto e non pare vi siano ragioni di attrito reciproco : "il lavoro è già ben organizzato - esse dicono - ogni infermiera sa cosa deve fare il lunedì, il martedì, il mercoledì, e così via". Le infermiere ammettono però che non si fa molto per il recupero delle malate, con azioni accurate e individuali (che pare per l'addietro si facessero e abbiano condotto a un certo numero di dimissioni). Una di loro afferma che con l'orario continuato di un tempo, anche se più pesante, "si viveva meglio dal di dentro la vita del reparto e si potevano seguire meglio le ammalate". Tutte ad ogni modo affermano che con gli psicofarmaci e le nuove terapie la vita del-

l'ospedale si è trasformata e, senza confronto, "non è più quella di prima".

Le ammalate - salvo alcune aggressive e irrequiete - sono in genere asteniche e sono curate con psicofarmaci. Le infermiere non conoscono l'anamnesi delle ammalate e anche sulla loro diagnosi hanno idee vaghe : dicono di attenersi alle indicazioni del medico. Esse ammettono tuttavia che la maggior parte delle lungodegenti, ora irrecuperabili o almeno difficilmente recuperabili, forse si sono ridotte in queste condizioni a causa degli anni trascorsi in ospedale.

Attività delle ammalate : oltre ai lavori di riordino già descritti, le ricoverate dispongono nel reparto di una piccola biblioteca, tenuta da una malata per il prestito dei libri; recentemente sarebbero stati comperati un certo numero di volumi nuovi, tenendo conto dei gusti delle malate. Queste ultime però - come si è detto - sono per lo più anziane e deteriorate: sicché la maggior parte ha pochi interessi (due sole malate, durante la nostra visita, stavano davanti alla televisione, pochissime erano in giardino, la maggioranza stava già a letto). (Nel reparto non arrivano giornali quotidiani, salvo sporadicamente). Suora e infermiere affermano che in passato sono state effettuate gite collettive del reparto, alle quali ben poche ricoverate hanno partecipato con entusiasmo. Recentemente alle malate è stato proposto di trascorrere qualche tempo, anche in albergo, nei loro paesi d'origine; ma la stragrande maggioranza avrebbe rifiutato di muoversi, preferendo non abbandonare l'ospedale.

Risulterebbe che, in genere, le malate ricevono visite dai parenti; il rifiuto verso il mondo esterno delle malate denota però, a nostro avviso, un legame assai debole con la famiglia che, anche quando non scompare del tutto, evidentemente tende a non riavere in casa il malato di mente (ciò è stato confermato del resto da alcuni colloqui con le ricoverate).

In conclusione, da questa nostra visita peraltro breve, si possono trarre - ci pare - queste osservazioni generali : il reparto, pur ben tenuto e ordinato, è un tipico ambiente "manicomiale"; le malate vi vegetano più o meno confortevolmente, senza alcuna prospettiva di cambiamento, la cui sola idea, anzi, sembra spaventarle e inquietarle. Non ci pare che si faccia molto per smuovere quotidianamente questo immobilismo di fondo. Molte malate sono ricoverate da 20, 30 anni (!); parlare di recupero in queste condizioni è indubbiamente difficile; però le energie del personale, dalla capo-reparto alle inservienti, sembrano concentrate essenzialmente sul buon funzionamento esteriore: ordine e pulizia infatti non mancano. Ma su quanto di questa efficienza si traduca in vero progresso, oltreché in semplice conservazione, per le malate, è lecito avere parecchi dubbi. E' certo che pesa sul reparto l'età avanzata e la lungodegenza di molte malate. In altri reparti tuttavia - certo anche per la presenza di malate più giovani - accanto a un maggior disordine e più confusione, si percepiva anche un pulsare di vita, un aleggiare di speranza o di attese sia pure ansiose, che qui mancano.

(Piccola osservazione : in questo reparto non si è vista nessuna malata fumare, nessuna mostra segni esteriori di civetteria; la suora è pronta ad invitare amichevolmente ma senza indugi a ricomporsi e ricoprirsi le malate che, in prossimità dei gabinetti, stanno con le sottane alzate o sono senza mutande).